Roche

从病理能力建设到患者导入增长

聚焦五步法转化达标医院与病理能力卡点医院，以专业赋能解除导入瓶颈，形成业务增长闭环。

70+
参会医生

2 × 5
天数 × 专题

导入率 ↑
核心业务结果

业务命题

从孤立学习走向持续连接

复杂病例增加、亚专科资源不均与 MDT 协作要求，让“一次性培训”难以承接真实工作场景。

01
诊断复杂度持续上升
常规阅片之外，疑难病例需要更系统的诊断框架与专家经验。

02
区域医生容易“单兵作战”
亚专科专家稀缺，学习与答疑缺少稳定、可回访的连接机制。

03
病理在 MDT 中需要更强表达
从给出结论，升级为参与临床决策和治疗路径讨论。

核心业务逻辑

病理科参会不是终点，导入率提升才是闭环

01 / TARGETING

五步法识别目标医院

转化率已达标：放大病理协同价值

导入受阻：病理能力成为关键卡点

→

02 / ENGAGEMENT

定向邀请病理科参会

围绕真实病例与院内导入卡点设计内容，让参会对象与业务问题精准匹配。

→

03 / CAPABILITY

提升诊断与 MDT 能力

强化检测理解、病例判断和跨科沟通，降低病理端不确定性。

→

04 / OUTCOME

推动患者导入率提升

病理端能力与协同改善，转化为更顺畅的患者识别、检测和导入。

最重要业务闭环：病理科能力提升 → 导入卡点解除 → 患者导入率提升

衡量：参会医院会前 / 会后导入率变化

项目策略

把课程设计成一条学习路径

现场解决“会不会”，连接解决“遇到时找谁”。

以病例为核心、专家为节点、区域为网络，让培训从知识输入走向长期协同。



执行路径

两天活动，四个关键动作

STEP 01

精准邀约

基于五步法，锁定转化达标医院及病理能力影响导入的卡点医院。

32 人

STEP 02

实战教学

围绕 5 个主题，结合典型病例建立诊断思维。

2 天 × 5 题

STEP 03

数据复盘

用问卷和反馈识别内容偏好、未满足需求与升级方向。

21 份

STEP 04

病例共识

将阅片、MDT 和答疑机制延伸到会后日常工作。

长期连接

执行原则：**少讲概念，多讲病例；少做单向传播，多做可回访互动。**

现场时刻

从听课，到共同推演



专家授课与病例拆解



互动讨论

70+

专业连接在现场发生



区域共学



问题带回日常

量化结果

不是“办完一场会”，而是验证一条路径

70+

参与医生

32 名定向邀请，叠加 40+ 自主参会，体现主题吸引力与区域触达。

90%

最认可专题授课

结构化讲解仍是最具确定性的学习入口。

81%

希望强化阅片

需求进一步指向常规阅片和疑难诊断。

71%

首选 MDT 实践

医生期待从诊断走向临床决策协同。

14

主动感谢留言

情感反馈验证了专业体验与关系价值。

关键洞察

医生需要的不只是一场好课，而是遇到难题时仍能找到答案。

基于 21 份有效问卷及现场反馈

更深

延长病例讨论

减少泛讲，增加疑难病例的诊断推演与关键分歧。

更多

扩大真实案例池

由专家单向供给，升级为区域共建、持续积累。

更频

建立固定触点

用线上答疑和阶段复盘保持学习节奏。

更广

连接 MDT 场景

让病理观点在临床决策中被看见、被采用。

项目价值从“满意度”升级为：**病理能力提升 × 导入卡点解除 × 患者导入率提升**

Roche

下一步

构建三层学习生态

持续追踪目标医院病理端变化，让专业赋能稳定转化为导入增长。

LAYER 01

持续学习网络

固定主题节奏、线上答疑与病例回访，保持专业连接。

LAYER 02

区域师资梯队

识别核心讲者与青年骨干，形成可扩展的内容供给。

LAYER 03

导入率复盘

按医院追踪会前会后导入率，验证病理能力建设的业务贡献。

负责人：东区–PSM–Luke

从病理赋能 → 卡点解除 → 导入增长

09